

항혈전제 복용자 내시경 전 상담표

아스피린·플라빅스·와파린·엘리퀴스 같은 약은 **출혈을 늘릴 수 있지만**, 임의로 끊으면 **심근경색·뇌졸중·스텐트 혈전** 위험이 커질 수 있습니다. 약 중단 여부는 검사 종류와 혈전 위험을 함께 보고 의료진이 결정합니다.



STEP 1 — 복용 중인 약을 모두 알려주세요

항혈소판제 · 피가 엉기는 것을 막는 약

아스피린 · Aspirin
클로피도그렐 · 플라빅스, Plavix
프라수그렐 · 에피엔트
티카그렐러 · 브릴린타
실로스타졸 · 프레탈 등

항응고제 · 혈전 생성을 억제하는 약

와파린 · Warfarin
아픽사반 · 엘리퀴스
리바룩사반 · 자렐토
에독사반 · 릭시아나
다비가트란 · 프라닥사

STEP 2 — 상담 때 꼭 확인할 5가지

- 1 검사 종류 — 단순 관찰·조직검사인지, 용종절제·점막절제처럼 출혈 위험이 높은 시술인지 확인합니다.
- 2 약 이름·용량·마지막 복용 시간 — 약 봉투, 처방전, 복약 앱 사진을 가져오세요.
- 3 왜 먹는 약인지 — 심장 스텐트, 뇌졸중, 심방세동, 혈전증, 판막수술 여부가 중요합니다.
- 4 최근 사건 — 1년 이내 심장 스텐트·심근경색·뇌졸중·폐색전증이 있었다면 반드시 먼저 알려주세요.
- 5 신장기능·INR — DOAC은 신장기능, 와파린은 INR 결과에 따라 일정이 달라질 수 있습니다.

검사 종류별 원칙 — 자가 결정 금지

출혈 위험 낮은 검사

예: 진단 위내시경·대장내시경, 단순 조직검사
원칙: 많은 경우 약을 유지하거나 최소 조정으로 진행합니다.
DOAC: 검사 당일 아침 복용 여부는 의료진이 확인합니다.

출혈 위험 높은 시술

예: 용종절제, EMR/ESD, 내시경 지혈·확장술
원칙: 약제별 조정이 필요할 수 있습니다.
중요: 스텐트·뇌졸중 위험이 높으면 처방의와 상의 후 결정합니다.

절대 하지 마세요

- 인터넷 표만 보고 약을 끊기
- 스텐트·뇌졸중 약을 임의 중단
- 약 이름을 모른 채 검사 당일 내원
- 중단한 뒤 재개일을 확인하지 않기

내원 전 준비

- 약 봉투 또는 처방전 사진
- 심장 스텐트 시술 날짜
- 최근 뇌졸중·혈전증 진단일
- 최근 Cr/eGFR, 와파린 복용자는 INR

